Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 15ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F:( )

Processo nº **0167901-87.2022.8.17.2001**

AUTOR(A): JOSE RICARDO CORDEIRO BEZERRA

RÉU: BRADESCO SAÚDE S/A

SENTENÇA

Vistos, etc…

JOSÉ RICARDO CORDEIRO BEZERRA, já qualificado, através de seu advogado legalmente constituído, propôs a presente **AÇÃO COMINATÓRIA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, CC DANOS MORAIS** em face da **BRADESCO SAÚDE S/A,** alegando resumidamente que (id. 120468269):

1. É beneficiário de um dos planos de saúde administrados pela empresa Demandada desde 07/06/2017. O referido plano foi contratado sob a modalidade coletivo empresarial, com previsão de cobertura assistencial médica ambulatorial e hospitalar, com acomodação em enfermaria e abrangência geográfica nacional.
2. O Autor é portador de discopatia lombar con artrose facetáriua difusa na coluna lombar nos niveis L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1, com dor crônica lombar intermitente com crises que limitam marcha e movimento (CID R52.2, M 47.9, M51.1), apresentando quadro de lombalgia crônica e dor sacro ilíaca direito com irradiação para membro inferior direito e com parestesia virilha e coxa com claudicação intermitente, já tendo se submetido a vários procedimentos médicos, sendo estes: infiltração foraminal, punção discal, microneurolise múltiplas, desnervação de facetas, rizotomia percutânea de coluna lombar e discectomia L5-S1 percutânea.
3. Tais procedimentos ofereceram certa melhora e redução parcial das dores do Demandante, no entanto, houve severa piora nos ultimos 8 meses, estando as dores persistentes de modo intenso na região do quadril, pernas, sacral, lombar, torácica, nas proximidades do cóccix e embaixo dos pés, o que tornou necessário seu afastamento das atividades laborativas a partir de outubro de 2017, estando atualmente guarnecido por benefício do INSS, conforme extrato de pagamentos e documentos previdenciários em anexo.
4. De acordo com os relatórios médicos elaborados pelo Dr. Paulo Melo (CRM/PE n. 17.367), em razão da patologia que o acomete, o Autor precisa ser submetido ao procedimento de rizotomia L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1: x5 seguimentos, com bloqueio peridual X1 seguimentos.
5. O seu quadro clínico lhe gera diversas limintações:

O PACIENTE ENCONTRA-SE COM PREJUIZO EM SUA QUALIDADE DE VIDA E EVOLUI COM DIFICULDADE PARA RETORNAR AO TRABALHO USUAL EM DECORRENCIA DA LOMVALGIA CRÔNICA. É NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO MINIMAMENTE INVASIVO PARA REDUZIR OS SINTOMAS DE DOR LOMBAR E PERMITIR UMA MELHOR REABILITAÇÃO DO PACIENTE. CASO PERSISTAM COM DOR LOMBAR CRÔNICA, SEM TRATAMENTO ESPECIFICO, ATUALMENTE O MAIS INDICADO SERIA A RIZOTOMIA LOMBAR CONFORME MENCIONADO ACIMA, EXISTE UMA MAIOR PREDISPOSIÇÃO A CRONIFICAÇÃO DA DOENÇA E MAIOR DIFICULDADE DE MELHORA DOS SINTOMAS DE DOR. O PACIENTE PERMANECE COM LIMITAÇÃO DA MOBILIDADE E DIFICULDADE DE REALIZAR SOBRECARGA MECANICA A REGIÃO LOMBAR.

6. Deu entrada no pedido de autorização de cirurgia e materiais. Ocorre que a empresa Demandada não autorizou os procedimentos, sob a seguinte justificativa: "Código 31403336 e OPME restritos pois não foram apresentados laudo de bloqueio facetária de prova como preconiza a RN 4652 em sua DUT62, item 1/b (anexo ii do ROL de procedimentos da ANS) p/ realização de Rizotomia Percutânea COM RADIOFREQUENCIA). 16.11.2022-BL/NVL", consoante negativa em anexo.
7. O posicionamento da empresa Demandada é totalmente abusivo, visto que, ao não autorizar o procedimento requerido, está afrontando diretamente o direito à saúde e à vida do Requerente.
8. Se a doença a que está acometida o Demandante é coberta pelo contrato realizado entre as partes, não pode o Demandado limitar procedimento, sob pena de inviabilizar o próprio objeto do contrato.
9. A lista de procedimentos da ANS prevê apenas a cobertura mínima obrigatória, constando rol exemplificativo, motivo pelo qual deve ser conjugada com os princípios do CDC e da lei 9656/98.

Pelo que, requereu a concessão da tutela de urgência, determinando-se que a Requerida AUTORIZE e CUSTEIE, consoante relatórios médicos anexos do Dr. Paulo Melo (CRM/PE 17.367), o PROCEDIMENTO DE RIZOTOMIA L1-L2, L2-L3, L3 L4, L4-L5, L5-S1: X5 SEGUIMENTOS, COM BLOQUEIO PERIDUAL X1 SEGUIMENTOS, SENDO O PROCEDIMENTO FEITO BILATERALMENTE DEVENDO UTILIZAR 4 CANULAS PARA RIZOTOMIA DA LOMBAR, com todo o material necessário, sendo estes: - OPME – 04 CÂNULAS PARA RIZOTOMIA DA LOMBAR. FORNECEDOR: AXIAL, NEUROPERK OU NORDESTE IMPANTES.
Em sede de cognição exauriente, requereu: (a) a confirmação da tutela; e (b) reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Despacho concedendo a gratuidade de justiça e intimando a demandada para se manifestar sobre o pedido de tutela (id. 95817590).
Manifestação da demandada (id. 122950686).

A demandada apresentou a sua contestação (id. 127136082), onde suscitou:
a) IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

b) NO MÉRITO, alega, resumidamente, que:
1. A apólice coletiva foi implantada em 07/06/2017; mesma data de inclusão deste titular.

2. Em 26/10/2022 foi solicitada autorização para internação em caráter eletico com data prevista para 27/10/2022, no HOSPITAL PORTUGUES / Dr. PAULO SERGIO SANTOS MELO, visando realização do procedimento rizotomia percutânea p/ segmento qualquer método em quantidade 05, conforme informado pelo hospital.
3. Salientamos que o hospital não incluiu a solicitação de autorização para realização do procedimento bloqueio peridural ou subaracnóideo com corticoide e que na guia de solicitação de internação é apenas descrito: "paciente com quadro de dor lombar intensa crônica com piora há 4 meses. É portador de discopatia lombar com espondiloartrose facetaria. RNM da coluna lombar com doença degenerativa discal lombar com artrose facetaria".
4. Após análise; foi negada autorização – mesmo após reanálise – para o procedimento e para as cânulas a ele relacionadas:

22/11/2022	11:15:10	**Mantida negativa: Código 31403336 e OPME restritos pois não foi apresentado laudo de bloqueio facetaria de prova como preconiza a RN 465 em sua DUT62, item 1/b (anexo II do ROL de procedimentos da ANS) p/ realização de Rizotomia Percutânea COM RADIOFREQUENCIA**
18/11/2022	10:49:29	inf negativa da solic a ref gabriela
17/11/2022	08:28:38	CME - NEGATIVA Parecer: Código 31403336 e OPME restritos pois não foi apresentado laudo de bloqueio facetaria de prova como preconiza a RN 465 em sua DUT62, item 1/b (anexo II do ROL de procedimentos da ANS) p/ realização de Rizotomia Percutânea COM RADIOFREQUENCIA).16/11/2022-BL//NVL
16/11/2022	11:40:29	Código 31403336 e OPME restritos pois não foi apresentado laudo de bloqueio facetaria de prova como preconiza a RN 465 em sua DUT62, item 1/b (anexo II do ROL de procedimentos da ANS) p/ realização de Rizotomia Percutânea COM RADIOFREQUENCIA)

5. Nesse sentido, cumpre esclarecer que a apólice em questão foi contratada após a vigência da Lei 9.656/98 sendo, portanto, vinculada quanto à cobertura ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, e às suas Diretrizes de Utilização.
6. De acordo com a Anexo II do Rol de Procedimentos da ANS / RN 465, vigente à partir de 01/04/2021, DUT de nº 62 que trata da cobertura obrigatória para o procedimento RIZOTOMIA COM RADIOFREQUENCIA, a referida cobertura precisa que sejam preenchidos todos os critérios do GRUPO I - que em sua alínea "b" elenca a redução > 50% da dor referida pela VAS após infiltração facetaria utilizando anestésico local e, em função de não haver relato do médico assistente neste sentido, tratar-se de procedimento de cobertura não obrigatória.
7. Ademais, a negativa de procedimentos não constante nas Diretrizes de Utilização e no Rol de procedimentos da ANS está devidamente amparada nas previsões contratuais da apolice.
8. Não há danos morais.

Pelo exposto, requereu o acolhimento da impugnação à gratuidade de justiça e a total improcedência da Ação.

Réplica de id. 132846881.
Decisão indeferindo o pedido de tutela (id. 133417964).
Petição autoral informando que interpôs Agravo de Instrumento (id. 139642403).
Despacho de provas (id. 162775464), sem qualquer pedido de dilação probatória.
Razões Finais demandada (id. 165983628).
Razões Finais demandante (id. 193542612).

ISSO POSTO, DECIDO:

1. DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE:

Antes de enfrentar o mérito da demanda, faço as seguintes ponderações importantes para o caso concreto:

A Constituição Federal prescreve em seu artigo 1º, inciso III que:

> Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
> (...)
> III - a dignidade da pessoa humana.
> (...)

Especificamente em seu artigo 5º, que trata dos direitos e garantias individuais, prescreve a inviolabilidade do direito à vida, que em uma interpretação hodierna significa uma vida com qualidade, de forma que está umbilicalmente ligado a higidez do próprio corpo humano que a possui.
Ora, a vida é sem dúvida alguma o mais importante de todos os valores, pois dele emana a eficácia de todos os demais valores constitucionalmente protegidos, *v.g.*, saúde, moradia.
Dessa forma, é inafastável a necessidade do Estado preservar a vida dos indivíduos, prestando todo o auxílio necessário para que, com esse direito assegurado, possa exercer todo o feixe de direitos fundamentais que dele emanam.
O artigo 196 da Carta Política, por sua vez, prescreve que:

> Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A Constituição também prescreve, agora no artigo 199, que:

> Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Verifica-se pela leitura dos artigos supracitados que a iniciativa privada pode promover à assistência à saúde, mas deve respeitar as normas constitucionais que versem sobre a garantia da saúde dos pacientes, evidentemente, daquele grupo fechado beneficiário do serviço.

É com esse norte que se deve interpretar a relação existente entre as partes e objeto deste processo, sempre lembrando da proteção constitucional dada à vida como o valor mais importante protegido constitucionalmente.

2. DA NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES:

De mais a mais, destaco, ainda, que a relação objeto da presente lide é relação de consumo, regulada, por conseguinte, pelo Código de Defesa do Consumidor.

No seu artigo 2º, o referido Código estabelece que *Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final*, nessa definição se enquadra facilmente o requerente, pois é segurado do plano de saúde demandado, possuindo, portanto, natureza de consumidor *standard,* conforme estabelece a boa doutrina.
Doutra banda, inegavelmente o requerido é fornecedor de serviço posto no mercado de consumo, senão vejamos, o artigo 3º, *caput* e § 2º da Lei em tela:

> Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Ao meu ver, é desnecessária uma discussão mais aprofundada sobre a aplicação do CDC, pois é entendimento pacífico nos Tribunais que a relação em casos como o em tela é típica relação de consumo.
O STJ, inclusive, tem entendimento sumulado nesse sentido (Súmula 608-STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão).

Nessa direção, sendo a relação de consumo, é logicamente aplicável a legislação consumerista ao caso concreto.

3. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA:

A parte ré se insurge quanto à gratuidade de justiça requerida pela parte autora e deferida por este Juízo, alegando que inexistem provas de tal necessidade de concessão.
Pois bem, ao tratar da gratuidade de justiça, o NCPC prescreve em seu artigo 98 que:

> Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Nessa seara, constata-se que não existe um valor limite que a pessoa deve auferir, nem se exclui pessoas como beneficiários da gratuidade *a priori* pela profissão que ela exerce ou por outras justificativas, pois o motivo para a concessão do benefício é a falta de recurso para pagar as custas sem ter que dispor do mínimo necessário para sua sobrevivência, de forma que o termo "pobreza na forma da lei" não é sinônimo de miserabilidade material.
De mais a mais, o mesmo diploma normativo, agora em seu artigo 99, §§ 2º e 3º que:

> Art. 99. (...)
> § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
> § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Extrai-se das normas supra que o juiz deve indeferir o pedido se nos autos houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, sendo presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Faz-se necessário, portanto, analisar se no caso em comento há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, e a vistas dessa análise manter ou revogar a gratuidade anteriormente concedida, uma vez que a presunção de insuficiência é *iuris tantum*, ou seja admite prova **a cargo da parte contrária**, senão vejamos julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco neste sentido:

> PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. **DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DO REQUERENTE. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. DESCONSTITUIÇÃO. ÔNUS DA PARTE ADVERSA**. NÃO É SUFICIENTE PARA ELIDIR ESSA PRESUNÇÃO LEGAL O FATO DE TER SIDO CONTRATADA TEMPORÁRIA DO MUNICÍPIO OU ESTAR PATROCINADA POR ADVOGADO PARTICULAR. VERACIDADE NÃO INFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
> (TJ-PE - AI: 3629576 PE, Relator: Ricardo de Oliveira Paes Barreto, Data de Julgamento: 26/03/2015, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/04/2015)

Dentro deste cenário, após a concessão da gratuidade, cabia à parte demandada trazer nos autos comprovação da desnecessidade da concessão da gratuidade, face à presunção de veracidade da declaração do autor.
Entretanto, a parte ré não fez qualquer prova de que o autor não faz jus ao benefício já concedido por este Juízo, sendo insuficiente para afastar a presunção o fato da parte demandante ter contratado advogado particular.

Pelo que, outra solução não há que não seja não acolher a impugnação à Justiça Gratuita, uma vez que a impugnante não provou que a parte impugnada não faz jus ao benefício concedido, ônus que lhe incumbia face a presunção de veracidade constante no art. 99, §3º, do CPC.

4. DOS FATOS INCONTROVERSOS:

Faz-se necessário elucidar que o Digesto Processual Civil prescreve em seu artigo 36, que cabe (...) *ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir*.
De mais a mais, prescreve ainda o artigo 341 que *Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas* (...).

Ora, analisando a contestação da ré, observo que a tese da defesa é que de fato houve a negativa de cobertura, todavia sustenta que a negativa é lícita, de forma que não deve a ré ser compelida a custear o procedimento em questão e nem reparação por danos morais.

Dentro deste cenário, percebe-se que é incontroverso, face a não impugnação específica, que: (a) o demandante é segurado da demandada e estava em dia com suas mensalidades; (b) foi diagnosticado com iscopatia lombar com artrose facetáriua difusa na coluna lombar nos niveis L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1, com dor crônica lombar intermitente com crises que limitam marcha e movimento (CID R52.2, M 47.9, M51.1), apresentando quadro de lombalgia crônica e dor sacro ilíaca direito com irradiação para membro inferior direito e com parestesia virilha e coxa com claudicação intermitente; (c) submeteu-se a vários procedimentos médicos, sendo estes: infiltração foraminal, punção discal, microneurolise múltiplas, desnervação de facetas, rizotomia percutânea de coluna lombar e discectomia L5-S1 percutânea que não atingiram os finas almejados; (d) houve severa piora nos ultimos 8 meses, estando as dores persistentes de modo intenso na região do quadril, pernas, sacral, lombar, torácica, nas proximidades do cóccix e embaixo dos pés, o que tornou necessário seu afastamento das atividades laborativas a partir de outubro de 2017,

estando atualmente guarnecido por benefício do INSS; (e) o médico que acompanha o paciente indicou o procedimento de rizotomia L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1: x5 seguimentos, com bloqueio peridual X1 seguimentos; e (f) a demandada não autorizou os procedimentos, sob a seguinte justificativa: "Código 31403336 e OPME restritos pois não foram apresentados laudo de bloqueio facetária de prova como preconiza a RN 4652 em sua DUT62, item 1/b (anexo ii do ROL de procedimentos da ANS) p/ realização de Rizotomia Percutânea COM RADIOFREQUENCIA). 16.11.2022-BL/NVL".

Ou seja, na sua contestação a ré não nega que o pedido de cobertura foi feito e nem a necessidade e utilidade da cirurgia, pois sua defesa caminha no sentido de tentar provar que a negativa foi devida, em outras palavras: Que não está nem legalmente nem contratualmente obrigada a custeá-los, tendo em vista que o caso da autora não está abarcado no DUT da ANS para o caso do procedimento cirúrgico prescrito.

Vê-se, portanto, que o ponto controvertido do caso posto em apreciação é unicamente verificar se a negativa promovida pela ré é legítima ou ilegítima.

5. DA (I)LEGALIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA:

Prima facie, destaco que foi anexado aos autos Laudos médicos em que consta que o autor é portador de discopatia lombar com artrose facetária difusa na coluna lombar nos níveis L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1, com dor crônica lombar intermitente, ora demandante, e, ainda, o fato dela ter se submetido a inúmeras tentativas de tratamento conservador, que não resolveram deu problema, além de piora de sua situação que gerou, inclusive, o seu afastamento do trabalho.
Segue o Laudo Médico de id. 132849170:

LAUDO MÉDICO

O SR. **JOSÉ RICARDO CORDEIRO BEZERRA**, 43 ANOS, ESTÁ EM TRATAMENTO PARA HÉRNIA DE DISCO DORSAL NO NÍVEL T7-T8 COM COMPRESSÃO MEDULAR E HÉRNIA DE DISCO LOMBAR DE L2 A S1. PACIENTE EVOLUI COM DOR CRÔNICA QUE NÃO MELHOROU COM O TRATAMENTO CLÍNICO, FISIOTERAPIA, INFILTRAÇÃO DA COLUNA E RIZOTOMIA LOMBAR. REALIZOU A ÚLTIMA INFILTRAÇÃO FORAMINAL DA COLUNA EM 29/11/2021.

COMO NÃO HOUVE SUCESSO COM O TRATAMENTO CONSERVADOR E APENAS ALÍVO TEMPORÁRIO DA DOR COM A INFILTRAÇÃO DA COLUNA, SOLICITO TRATAMENTO PARA DOR LOMBAR COM A REALIZAÇÃO DE RIZOTOMIA LOMBAR EM L2-L3, L3-L4, L4-L5 E L5-S1.

PACIENTE ESTÁ COM MUITA DIFICULDADE PARA SE LOCOMOVER,E FAZER ESFORÇO COM A COLUNA LOMABR E MEMBROS INFERIORES. SEM CONDIÇÕES DE EXERCER SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS COMO GERENTE DE LOGÍSTICA. SUGIRO AFASTAMENTO DO TRABALHO POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS).

CID 10: M51.1 E M51.2

RECIFE, 13 DE SETEMBRO DE 2022

Vejamos, ainda, o Laudo de id. 132849171:

SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

O PACIENTE JOSÉ RICARDO CORDEIRO BEZERRA, CPF: 035.957.084-40, 43 ANOS, ENCONTRA-SE COM QUADRO DE DOR LOMBAR INTENSA CRÔNICA COM PIORA HÁ 8 MESES. É PORTADOR DE DISCOPATIA LOMBAR COM ARTROSE FACETÁRIA DIFUSA DA COLUNA LOMBAR NOS NÍVEIS L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5 E L5-S1. FOI REALIZADO BLOQUEIO FACETÁRIO E FORAMINAL EM OUTUBRO DE 2021 E OBTEVE BOA MELHORA DA DOR LOMBAR POR MAIS DE 11 MESES. TEM RNM DE COLUNA LOMBAR COM DOENÇA DEGENERATIVA DISCAL LOMBAR COM ARTROSE FACETÁRIA EM L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5 E L5-S1.

TEM COMO PROGRAMAÇÃO A ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA DOS NÍVEIS L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5 E L5-S1 BILATERALMENTE. SOLICITO AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CONFORME:

3.14.03.33-6 RIZOTOMIA: L1-L2, L2-L3, L3-L4, L4-L5 E L5-S1: **X 5 SEGMENTOS**

3.16.0216-9 BLOQUEIO PERIDURAL: **X1**

OPME – 04 CÂNULAS PARA RIZOTOMIA DA LOMBAR.

FORNECEDOR: AXIAL, NEUROPERK OU NORDESTE IMPANTES.

O PACIENTE ENCONTRA-SE COM PREJUÍZO EM SUA QUALIDADE DE VIDA E EVOLUI COM DIFICULDADE PARA RETORNAR AO TRABALHO USUAL EM DECORRÊNCIA DA LOMBALGIA CRÔNICA. É NECESSÁRIO A REALZIAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO MINIMAMENTE INVASIVO PARA REDUZIR OS SINTOMAS DE DOR LOMBAR E PERMITIR UMA MELHOR REABILITAÇÃO DO PACIENTE. CASO PERSISTA COM DOR LOMBAR CRÔNICA SEM TRATAMENTO ESPECÍFICO, ATUALMENTE O MAIS INDICADO SERIA A RIZOTOMIA LOMBAR CONFORME MENCIONADO ACIMA, EXISTE UMA MAIOR PREDISPOSIÇÃO DE CRONIFICAÇÃO DA DOENÇA E MAIOR DIFICULDADE DE MELHORA DOS SINTOMAS DE DOR. O PACIENTE PERMANECE COM LIMITAÇÃO DA MOBILIDADE E DIFICULDADE DE REALIZAR SOBRECARGA MECÂNICA À REGIÃO LOMBAR.

CID 10: M51.1 E M47

RECIFE, 07 DE DEZEMBRO DE 2022

Dr. Paulo Melo

Dr. Paulo Melo
Cirurgia da Coluna
CRM-PE 17.367

Vê-se, portanto, que está comprovado nos autos o insucesso do tratamento conservador e a indicação do procedimento cirúrgico negado administrativamente.

Destaco, ainda, que a negativa do plano de saúde se deu sob a justificativa de que não foi possível sua validação, pois a documentação enviada não atende os critérios da Diretriz de Utilização (DUT) estabelecida pela ANS para o procedimento em questão .

Dito isso, está devidamente comprovado nos autos, pelos documentos acostados à inicial, que de fato o médico que acompanha a paciente requereu o(s) procedimento(s) e que a sua cobertura foi negada com base na falta de cobertura contratual.

Ora, a Jurisprudência pátria é uníssona ao se posicionar pela abusividade da negativa do plano de saúde em não autorizar a realização de tratamentos prescritos pelos médicos responsáveis, uma vez que, sendo a especialidade coberta pelo plano em questão, cabe ao profissional habilitado promover o cuidado do paciente, requerendo os procedimentos necessários.
Desta feita, não cabe ao plano de saúde avaliar as prescrições médicas, fazendo juízo de valor do que deve ou não ser autorizado, ou seja: o contrato de seguro saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, mas não o tipo de tratamento necessário para cada uma delas.
No caso em comento, deve ser observado os princípios da boa-fé, da confiança, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, sendo vedado à seguradora perceber por anos a contribuição do segurado para se esquivar da cobertura do tratamento indispensável ao tratamento do segurado, justamente quando do surgimento da doença
O Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco se filia ao posicionamento aqui esposado reiteradamente quanto à abusividade da negativa de autorização de procedimentos, vejamos julgados recente a respeito do tema:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE AGRAVO EM APELAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA E MATERIAL INDICADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. IMPLANTE DO SISTEMA ANGEL/MED GUARDIAN. APLICA-SE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS ENVOLVENDO OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE QUE ATUAM NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. NÃO É POSSÍVEL À OPERADORA LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO OU MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS. CABE AO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O PACIENTE A ESCOLHA. DECISÃO TÉCNICA. PRECEDENTES. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. MANTIDA A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. AGRAVO LEGAL NÃO PROVIDO.
(TJ-PE - AGV: 3991422 PE, Relator: Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo, Data de Julgamento: 15/12/2015, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/01/2016)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CDC. RECURSO DE AGRAVO EM APELAÇÃO. NA ORIGEM: AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRÁTICA ABUSIVA E NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLOCAÇÃO "UTEROSCÓPICA DE DUPLO J". EXCLUSÃO CONTRATUAL. ILEGALIDADE. CIRURGIA REQUERIDA SEGUNDO DIAGNÓSTICO DO PROFISSIONAL COMPETENTE. DEVER DA OPERADORA DE SAÚDE EM CUSTEAR O TRATAMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO APELO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO CAPAZ DE ENSEJAR A REVISÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂMIME.
(TJ-PE - AGV: 4034788 PE, Relator: Josué Antônio Fonseca de Sena, Data de Julgamento: 20/10/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2015)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HEMODIÁLISE. EXCLUSÃO CONTRATUAL. ILEGALIDADE. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PLANO DE SAÚDE NÃO PODE LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO. DEVER DA OPERADORA DE SAÚDE EM CUSTEAR O TRATAMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO APELO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO CAPAZ DE ENSEJAR A REVISÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂMIME.
(TJ-PE - AGV: 4156727 PE, Relator: Josué Antônio Fonseca de Sena, Data de Julgamento: 22/12/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2016)

PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO E MEDICAMENTOS INDICADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1- Procedimento solicitado por profissional médico como medida imprescindível ao tratamento da saúde do segurado. 2- Não pode ser negada cobertura a tratamento e medicamentos pelo simples fato de não constarem no guia da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, uma vez tenham sido prescritos pelo médico assistente e a enfermidade a ser tratada esteja prevista no contrato firmado entre as partes. 3- Cabível a indenização por danos morais em decorrência do agravamento do abalo psicológico em que se encontra o paciente, estabelecida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4- Montante fixado a título de danos extrapatrimoniais em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-PE - AGV: 3127691 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 25/09/2013, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2013)

TJ-PE - Apelação APL 3701862 PE (TJ-PE) (http://tj-pe.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/18393apl-3701862-pe) Data de publicação: 27/04/2015 Ementa: Apelação Cível. Plano de saúde. Negativa de cobertura de exame de Tomografia de

> Coerência Ótica - OCT. Danos morais configurados. Manutenção do valor indenizatório. Negado provimento ao recurso. Decisão unânime. I - Pode o contrato de seguro saúde limitar as doenças a serem cobertas, mas não o tipo de tratamento necessário para cada uma delas. II - A medicina em constante evolução, razão pela qual novas tecnologias relacionadas a exames e procedimentos médicos surgem a todo momento. Deste modo, não se pode falar em ausência de cobertura contratual de determinados exames que provavelmente nem existiam à época da contratação do plano de saúde em questão. IV - Nos contratos de plano de saúde devem incidir os princípios da boa-fé, da confiança, da hipossuficiência e da vulnerabilidade não sendo legítimo à seguradora perceber por anos a contribuição do segurado para se esquivar da cobertura do tratamento indispensável à permanência da vida dele justamente quando do surgimento da doença. V - A conduta da operadora em negar custeio ao medicamento necessitado pela paciente frustrou a legítima expectativa de ser protegida no momento de infortúnio. Nessa ocasião, o dano é claro e presumido, considerando-se o abalo à moral da vítima, pois teve o estado de tensão psicológica e de angústia intensificados pelo tratamento recusado.VI - Valor indenizatório mantido em R$8.000,00, pois chega a ser inferior aos parâmetros adotados pelo STJ e por esta Corte em casos análogos.VII - Recurso não provido por unanimidade

De mais a mais, mesmo que o tratamento não estivesse previsto no Rol de procedimentos obrigatórios da ANS não seria possível a sua negativa quando o médico assistente atesta a sua necessidade, pois há muito tempo a jurisprudência já definiu que o rol supracitado nada mais é que um rol de coberturas mínimas, senão vejamos julgado do Tribunal de Justiça de Pernambuco:

> Apelação Cível. Plano de saúde. Tratamento de radioterapia com técnica de modulação de intensidade no feixe. Negativa de cobertura. Abusividade. Incidência da legislação consumerista. Rol de procedimentos elencados pela ANS que serve apenas como referência para cobertura assistencial mínima. Dever de cobertura. Recurso não provido por unanimidade.
> I - Pode o contrato de seguro saúde limitar as doenças a serem cobertas, mas não o tipo
> de tratamento necessário para cada uma delas.
> II - Se o plano possui cobertura para a especialidade de oncologia e o tratamento mais eficiente a ser ministrado ao paciente nesse caso, segundo entendimento médico consiste radioterapia com técnica de modulação de intensidade no feixe não há razão para excluir o referido procedimento da cobertura securitária, sob pena de se negar ao beneficiário o tratamento adequado à sua enfermidade e, por consequência, ferir a própria finalidade do contrato firmado entre as partes.
> III - No caso, o médico assistente do segurado justificou a necessidade do tratamento em questão por ser a única opção terapêutica com finalidade curativa e ainda destacou a necessidade de urgência da autorização de cobertura devido à velocidade de aumento do tumor.
> IV - O Rol da ANS não é taxativo, contendo apenas a referência para a cobertura assistencial mínima obrigatória dos planos de saúde.
> V - A previsão dos riscos segurados e as limitações de cobertura no contrato de seguro não consistem, por si só, em ilegalidade. No entanto, a possibilidade de predeterminar os riscos cobertos não justifica a estipulação de cláusulas abusivas e contrárias às disposições do CDC.VII - Recurso apelatório não provido por unanimidade.
> (Processo APL 3850531 PE Orgão Julgador 3ª Câmara Cível Publicação 14/01/2016 Julgamento 17 de Dezembro de 2015 Relator Francisco Eduardo Goncalves Sertorio Canto)

Quanto a este tema (taxatividade ou não do rol), destaco que tempos atrás existiu uma séria insegurança jurídica, pois a divergência entre a 3ª e 4ª Turmas do STJ afetou tal tema para análise.
Antes de a Corte definir sobre a taxatividade ou não do rol foi publicada nova Lei reforçando a taxatividade do rol, situação que levou o STJ (2ª Seção) a definir pela taxatividade rol, entretanto com algumas exceções, chegando-se a conclusão que a tese adotada foi a da taxatividade mitigada.
Entretanto, em 21/09/2022, foi sancionada nova Lei de nº 14.454/2022, que altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, e trata dos planos privados de assistência à saúde.

Nesta nova Lei as operadoras de planos de saúde estão obrigadas a financiar tratamentos que não estiverem na lista mantida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Desta feita, a discussão sobre a natureza exemplificativa ou taxativa do rol fora sepultada com a nova Lei 14.454/2022 que previu expressamente que tal rol é um rol de cobertura mínima.

De igual forma, caso eventualmente o DUT não preveja o procedimento cirúrgico para a situação do autor, cabe ao médico analisar o caso do paciente e adotar o procedimento mais adequado, prevalecendo, portanto, a prescrição do médico assistente.
Para que a negativa com base no DUT fosse possível, caberia a demandada ao menos comprovar nos autos uma alternativa terapêutica para o caso do paciente, não sendo lícito admitir a negativa do procedimento cirúrgico indicado sem qualquer outra alternativa, pois tal situação coloca o consumidor em desvantagem excessiva, pois na prática ficaria sem qualquer tratamento, tendo que suportar as dores físicas, limitações da vida e impossibilidade de trabalhar, além do agravamento da doença.
Em suma: tendo em vista que o tratamento tem cobertura contratual, conforme previsão expressa na Lei nº 9656/98, não se encontrando nas hipóteses de exclusão do Art. 10 da normativa, não se mostra razoável que o paciente seja privado do procedimento em sua plenitude ou obtenha cobertura parcial, que na prática equivale à negativa, por não alcançar o resultado esperado da terapêutica recomendada, porque, em tese, não se adequaria a todos os pressupostos da diretriz de utilização, quando tal circunstância sequer foi comprovada nos autos.

Por conseguinte prevendo a Lei a exemplificatividade do rol, não cabe a este Juízo acolher a defesa, de forma que se mostra ilegal a negativa de cobertura da técnica com base na suposta ausência de enquadramento no DUT, pois a Lei que trata dos planos de saúde, como já esclarecido nesta sentença, prevê claramente que o rol é exemplificativo .

Por fim, segue julgado de casos análogos:

> APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. **PLANO DE SAÚDE**. PARALISIA CEREBRAL. **RIZOTOMIA** DORSAL SELETIVA. (...) **1. É dever da operadora do plano de saúde assegurar os procedimentos indicados pelo médico assistente como alternativa para o tratamento e a cura da beneficiária, nos termos do no art. 10, da Lei nº 9.656/98.** (...) **Dever de custeio do tratamento. Inteligência do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. (...)** 7. Recurso desprovido. (TJPE, APELAÇÃO CÍVEL 0011742-19.2022.8.17.2001, Relator: Des. Ruy Trezena Patu Júnior, 2ª Câmara Cível, julgado em 22/04/2024).

> APELAÇÃO CÍVEL. **DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO RIZOTOMIA. NEGATIVA DE MATERIAIS E PROCEDIMENTOS SOLICITADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. ABUSIVIDADE.** CONTRATO ANTIGO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CLÁUSULA EXCLUDENTE. DANO MORAL. RAZOABILIDADE.1. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para a sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. **2. O médico assistente é o profissional habilitado para apontar qual técnica é a mais segura e eficaz para o tratamento de seu paciente, inclusive visando um procedimento bem-sucedido e evitando-se que haja futura complicações na saúde do usuário do plano, implicando em outras demandas.** 3. A ré não comprovou que se trata de contrato antigo e não adaptado, como também não há sequer a indicação da cláusula contratual de exclusão de cobertura para o procedimento prescrito para o autor. (...) Recurso não provido. Decisão unânime. (TJPE, APELAÇÃO CÍVEL 0059679-25.2022.8.17.2001, Relator: Des. Ruy Trezena Patu Júnior, 2ª Câmara Cível, julgado em 28/03/2024).

> CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. **AGRAVO DE INSTRUMENTO**. PLANO DE SAÚDE ANTIGO E NÃO ADAPTADO. **SEGURADA PORTADORA DE DOR CRÔNICA EM REGIÃO LOMBAR, SACRAL E CÓCCIX, DE FORTE INTENSIDADE E INCAPACITANTE. LIMITAÇÕES DAS ATIVIDADES DIÁRIAS**. ESPONDILOARTROSE AVANÇADA E ARTROSE FACETÁRIA. **PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA VISANDO ALÍVIO MAIS DURADOURO DO QUADRO APRESENTADO. RIZOTOMIA FACETÁRIA LOMBAR, DO SACRO E CÓCCIX. RADIOFREQUÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA**. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. **De acordo com o laudo médico colacionado aos autos, a Autora é portadora de dor crônica em região lombar, sacral e cóccix, de forte intensidade e incapacitante, refratária ao tratamento clínico com polifarmácia analgésica e fisioterapia, evoluindo com muitas limitações de suas atividades de vida diária há 3 anos, não conseguindo permanecer em posição sentada por mais de cinco minutos. Indicação do procedimento de rizotomia facetária lombar, do sacro e do cóccix com radiofrequência. (...)** 2. Parte ré/apelante justifica a negativa de autorização também em razão de o plano de saúde da Autora ser antigo e não adaptado. (....) 9. Desprovimento do recurso. (TJPE, APELAÇÃO CÍVEL 0025054-62.2022.8.17.2001, Relator: Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo, 5ª Câmara Cível, julgado em 19/03/2024).

Desta feita, eventual alegação de que o contrato não cobre aquele procedimento ou que ele não consta no rol de coberturas obrigatórias da ANS ou em seu DUT não pode prosperar, uma vez que a doença é acobertada no contrato, o médico prescreveu o procedimento e indicou sua realização para salvaguardar a integridade física do paciente, ora demandante, e não existe outra opção terapêutica.

6. DA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS:

A respeito do pleito de danos morais, constato que o requerente sustenta que a negativa da ré em custear o procedimento cirúrgico gerou danos morais indenizáveis.
Quanto ao pleito em tela, trago à baila o artigo 14 do CDC que trata da responsabilidade do fornecedor de serviços:

> Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O artigo 6º, VI, do mesmo diploma legal, por sua vez prescreve que:

> Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
> (...)
> VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

Verifica-se, portanto, que a responsabilidade do fornecedor do serviço é objetiva, ou seja, a ilicitude da conduta, no sentido objetivo, aplicada ao caso concreto, com base nos artigos supra, depende de uma conduta contrária ao ordenamento que vai causar dano a outrem independente de culpa; faz-se necessário verificar, portanto, três requisitos: (a) Ação/omissão; (b) nexo de causalidade; (c) dano. Sendo esse o norte para a apreciação dos pedidos de danos morais.

É importante realçar que não se faz necessário analisar se houve falha na prestação do serviço, uma vez que neste manto sentencial já foi constatada a referida falha, pois a ré deixou de autorizar o procedimento quando era seu dever autorizar.
Pelo que, basta neste momento analisar se a falha na prestação do serviço gera dano moral indenizável e promover a definição *quantum* indenizatório.

Desta feita, vejamos se a não autorização da ré da cirurgia enseja danos morais indenizáveis, e para isso, faz necessário observar se os elementos da responsabilidade objetiva (ação, nexo causal e dano) são verificados no caso concreto.

Ora, o elemento (a) ação/omissão está configurado, uma vez que já foi suficiente esclarecido nesta sentença que a ré não autorizou o procedimento cirúrgico quando era seu dever autorizar.
O (c) dano também se verifica no caso em comento, vez que o procedimento só pode ser realizado com o deferimento da tutela.
Ora, não é razoável que se repute como mero aborrecimento o fato narrado, pois o demandante se viu sem a possibilidade de realizar o tratamento que precisava por resistência injusta da requerida em autorizá-lo, o que gera *angústia e intranquilidade, frustrando a legítima expectativa quanto à sua recuperação*, configurado, assim, o elemento nexo de causalidade (b).

O caso em comento carece de "grande esforço dogmático" para a caracterização dos danos morais, uma vez que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça é uníssono ao estabelecer que esse tipo de negativa promovida por planos de saúde gera dano moral *in re ipsa*, senão vejamos:

> AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC)- DEMANDA POSTULANDO **INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO NA NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE** - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO RECLAMO DA CONSUMIDORA PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, RECONHECENDO A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL E ARBITRADA A INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE.
> 1. **A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral**, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. **Caracterização de dano moral in re ipsa**. Precedentes.
> (...)
> 4. Agravo regimental desprovido.
> (Processo: AgRg no AREsp 144028 SP 2012/0002890-0. Relator(a): Ministro MARCO BUZZI. Julgamento: 03/04/2014. Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA. Publicação: DJe 14/04/2014)

***Ex positis*, na esteira destes entendimentos, levando em conta o caráter reparatório e pedagógico da reparação por danos morais, entendo como devido a título de danos morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do demandante.**

DECISÃO:

Posto isso, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado na inicial, e, por conseguinte:

a) Condeno a demandada a, no prazo de 10 dias, AUTORIZAR e CUSTEAR integralmente O PROCEDIMENTO DE RIZOTOMIA L1-L2, L2-L3, L3 L4, L4-L5, L5-S1: X5 SEGUIMENTOS, COM BLOQUEIO PERIDUAL X1 SEGUIMENTOS, SENDO O PROCEDIMENTO FEITO BILATERALMENTE DEVENDO UTILIZAR 4 CANULAS PARA RIZOTOMIA DA LOMBAR, com todo o material necessário, sendo estes: - OPME – 04 CÂNULAS PARA RIZOTOMIA DA LOMBAR. FORNECEDOR: AXIAL, NEUROPERK OU NORDESTE IMPANTES, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 80.000,00.

b) Condeno a demandada, ainda, a reparar o demandante - a título de danos morais - no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigidos monetariamente (IPCA) da data do arbitramento e acrescido de juros legais da data da citação (1% a.m. até 27/08/2023 e, a partir de 28/08/2023, SELIC, deduzido o valor do IPCA).

c) Condeno, por fim, a demandada no pagamento das custas processuais em favor do TJPE (valor do procedimento cirúrgico, somado a reparação por danos morais).

Pelo que **EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO**, com base no artigo 487, inciso I, do CPC.

Arbitro os honorários a serem pagos pela demandada em favor dos advogados da demandante no importe de 10% sobre o valor da condenação (valor do procedimento somado a reparação por danos morais).

Intimem-se as partes desta sentença.

Após o trânsito em julgado, determino que sejam tomadas todas as medidas legais para salvaguardar o interesse público no recolhimento das custas processuais, em favor do TJPE, pela demandada.

Cumpridas todas as determinações supra, arquive-se o processo.

P.R.I.

Recife, 17 de julho de 2025.

Juiz(a) de Direito

Assinado eletronicamente por: FERNANDO JORGE RIBEIRO RAPOSO
17/07/2025 13:05:28
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 209046403

25071713052856800000203565303

IMPRIMIR GERAR PDF